אלרגיה ואנאפילקסיס



עמוד 1: מה קורה בגוף · סימנים לפי מערכות · אפיפן

דף סיכום · פודקאסטים קלוד

מה קורה בגוף?

תגובה אלרגית
תגובת יתר של מערכת החיסון לחומר שאינו מסוכן.

אנאפילקסיס
2 מערכות או יותר, או אחת באופן נרחב. במקרים רבים מסכנת חיים.

ורגישות יתר?

תגובה מוגזמת **בלי** מערכת החיסון (למשל לקטוז ← תסמיני עיכול).

20%	3,500	300–380	8–14
מהאוכלוסייה	מקרים בשנה במד"א	מהם אנאפילקטיים	מקרי מוות בשנה

איך נוצרת אלרגיה?

חשיפה ראשונה ← **זיכרון חיסוני**. חשיפה שנייה ← הרבה נוגדני **IgE**, שנקשרים ל**תאי הפיטום (Mast)** בעור, בנשימה ובעיכול. האלרגן נקשר ← **דה גרנולציה** ← **היסטמין**: פריחה, גרד, אודם, נפיחות, נזלת. גם חשיפה ראשונה גדולה (יוד, עקיצות מרובות, תרופה לוריד) יכולה להספיק, ואצל אלרגי גם כמות זעירה.

היסטמין מבוקר: כיווץ סימפונות (לא לשאוף עוד) · הרחבת כלי דם (ניקוז) · פריסטלטיקה (החוצה) · חומצה (נטרול) · דמעות ונזלת (שטיפה). **בלי בקרה: אותם מנגנונים = התסמינים.**

שימו לב: דו פאזית: שני שיאים, בערך 4 שעות ביניהם. **גם מי שקיבל אדרנלין והשתפר מגיע לבית החולים.** ככל שהסימנים הופיעו מהר יותר אחרי החשיפה, מסוכן יותר.

סימנים לפי מערכות

נשימה



תחתונות: ברונכוספאזם, ריר, צפצופים, כניסת אוויר מופחתת. **עליונות:** צרידות וסטרידור (בצקת בגרון ובאפיגלוטיס), נזלת. **אנגיואדמה:** פלזמה בורחת לרקמה: שפתיים, לשון, פנים. בצקת בפנים ובדרכי האוויר = **סכנת חיים**.

עור, עיכול, לב, עצבים

עור (כ-88%): אורטיקריה וגרד מפושט (לחשוב גם על חצבת). **עיכול:** בחילות, הקאות, התכווציות, שלשולים. **לב וכלי דם:** כלי דם מתרחבים ודולפים, טכיקרדיה, שוק, הפרעות קצב, **תסמונת קוניס**. **עצבים:** חרדה, סחרחורת, עלפון, פרכוסים, עד חוסר הכרה.

קל-בינוני
אורטיקריה, נזלת ודמעת, חולשה, פלפיטציות, בחילות, כאבי בטן, קוצר נשימה קל עם צפצופים.

קשה
אנגיואדמה, קוצר נשימה משמעותי, צרידות, סטרידור, הקאות, שלשולים, **ירידה בפרפוזיה**: שינוי בהכרה, דופק מהיר וחלש, סיסטולי מתחת ל-90.

רמז: מערכת אחת שנחשפה (למשל התעטשות מאבק) = אלרגיה. אם האנמנזה מראה התקדמות לאנאפילקסיס ← אדרנלין לפי הפרוטוקול.

אפיפן: כלי המטופל ו-BLS

0.15 mg	0.3 mg
ילדים מעל 15 ק"ג (ירוק)	מבוגרים, וילדים מעל 30 ק"ג (צהוב)

1	2	3	4
אחוז במרכז, הסר את הנצרה הכחולה. כחול לשמיים	ירך חיצונית, 90°, בחוזקה עד קליק (גם דרך בגדים)	הצמד 10 שניות לפחות, ואז עסה 10 שניות	השלך למכל לפסולת חדה

בשטח: שאל אם המטופל כבר השתמש באפיפן (אוגדן עמ' 67). **בצוות ALS** שואבים אדרנלין ונותנים IM לפי פרוטוקול עמ' 66.

מקור: התסריט של הסרטון (מצגת הקורס והאוגדן). הדף חומר לימוד ואינו מהווה תחליף לפרוטוקול מד"א המעודכן. איורים: מקוריים, בסגנון הסרטון. אורטיקריה (מעובד): Enochlau, CC BY-SA 3.0, ויקישיתוף. אנגיואדמה בשפתיים (מעובד): James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0, ויקישיתוף. הזרקת מזרק אוטומטי (מעובד): AngelHM, CC BY-SA 4.0, ויקישיתוף.

אלרגיה ואנאפילקסיס



עמוד 2: גישה ותרופות · פרוטוקול מד"א

דף סיכום · פודקאסטים קלוד

גישה ותרופות

גישה ראשונית

ABC מהיר · חמצן לסטורציה 94–99% · נתיב אוויר? (פותחים פה, מחפשים בצקת) · קושי נשימתי? (מסכה, עד הנשמה מסייעת) · שוק? (הרמת רגליים). אנמנזה: כמה מהר, רקע אלרגי, חשיפות קודמות, הנשמה בעבר. מרחיקים מהגורם.

שימו לב: נתיב אוויר מעורב: אינטובציה מוקדמת או קוויקטראך. הטובוס הגדול ביותר + אחד קטן ממנו ב-1 מ"מ, בוז'י ווידאו כבר בניסיון הראשון.

מינונים

0.3–0.5 mg
אדרנלין IM בירך · עד 3 מנות, כל 10 דק'

10–20 mcg
אדרנלין IV PUSH, כל 2 דק' · רק בשוק עמוק

125 mg
סולומדרול IV · מנה אחת

2.5–5 mg
ונטולין באינהלציה · עד 3 מנות, כל 20 דק'

סליין 1 L/hr בקל-בינוני, 2–3 L/hr בקשה · **דופמין** 5–20 mcg/kg/min (היפופרפוזיה למרות אדרנלין ונוזלים) · **חוסמי ביתא:** + אירובנט 0.5 mg לאינהלציה · **זהירות** באדרנלין IV מעל גיל 40 או IHD.

פרוטוקול מד"א (אוגדן עמ' 66)

תגובה אלרגית (אנפילקסיס) מבוגר

1. **פעל** לפי גישה כללית · **שקול** אדרנלין I.M · **שקול** ניהול מתקדם של נתיב האוויר · **שקול** חמצן · **התקן** עירוי · **חבר** מוניטור
2. **קל-בינוני: שקול** ונטולין, סולומדרול, סליין 1 L/hr · אין שיפור ← **תן** אדרנלין I.M, **שקול** ונטולין, **תן** סולומדרול וסליין
3. **קשה: תן** אדרנלין I.M, **שקול** ונטולין, **תן** סולומדרול, **תן** סליין 2-3 L/hr · אין שיפור ← **שקול** אדרנלין I.V ודופמין, **המשך** סליין
4. **דום לב: בצע** החייאה מלאה · **תן** אדרנלין I.V, סליין 4-5 L/hr, סולומדרול
5. **המשך** ניטור וטיפול בפינוי דחוף · **בצע** הערכת מדדים חוזרת כל 5-10 דק' · **שקול** דיווח מקדים

בשטח: בתרשים כתוב **שקול** אדרנלין I.M, אבל בפועל מתייחסים אליו כ**תן**: נותנים מיד, עוד לפני שפותחים וריד.

דום לב ובית החולים

דום לב

אדרנלין **IV/IO בלבד**, 1 mg כל 2 דק' · סליין 4–5 L/hr · סולומדרול · סיבה נשימתית: טובוס, לפעמים נתיב כירורגי.

בבית החולים

טיפול דומה: נתיב אוויר, נוזלים, אדרנלין. סטרואידים (יעילות לא הוכחה), גלוקגון לנוטלי חוסמי ביתא, מרחיבי סימפונות. **אנטיהיסטמינים** מקלים רק על גרד ופריחה, לא על שוק ולא על נתיב האוויר. לא מגיב לכלום: **אקמו**.

3 דברים לזכור

1. **2 מערכות או יותר = אנאפילקסיס. ככל שהופיע מהר יותר, מסוכן יותר.**
2. **אדרנלין IM 0.3–0.5 mg בירך, עד 3 מנות כל 10 דקות. IV רק בשוק עמוק.**
3. **השתפר? עדיין לבית החולים: התגובה יכולה לחזור כעבור שעות.**

מקור: התסריט של הסרטון (מצגת הקורס והאוגדן). הדף חומר לימוד ואינו מהווה תחליף לפרוטוקול מד"א המעודכן. איורים: מקוריים, בסגנון הסרטון. הזרקת מזרק אוטומטי (מעובד): AngelHM, CC BY-SA 4.0, ויקישיתוף.